DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

IDENTIFICACIÓN

Paciente: MARIA NIVIA SERNA ARISTIZABAL **Identificación** CC 29991492
Edad: 76 AÑOS **Empresa:** NUEVA EPS S.A CONTRIBUTIVO-2025
Sala: QUIROFANO 3 **Fecha programación de cirugía:** 10/11/2026

Sede de Atención: SEDE PRINCIPAL

CIRUGÍAS

CANT	CÓDIGO	NOMBRE DE LA CIRUGÍA	Grupo Quirúrgico	UVR
1	**043108**	**NEURORRAFIA DE NERVIO EN PIERNA**	Y43	

Cirujano: FERNANDO AGUIRRE LASPRILLA **Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Vía: MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO

1	**770701**	**SECUESTRECTOMIA, DRENAJE, DESBRIDAMIENTO DE TIBIA O PERONE**	Y40	

Cirujano: FERNANDO AGUIRRE LASPRILLA **Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Vía: MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO

1	**780701**	**INJERTO OSEO EN TIBIA O PERONE**	Y42	

Cirujano: FERNANDO AGUIRRE LASPRILLA **Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Vía: MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO

1	**793713**	**REDUCCION ABIERTA DE FRACTURA DE TIBIA PROXIMAL CON FIJACION INTERNA**	Y43	

Cirujano: FERNANDO AGUIRRE LASPRILLA **Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Vía: MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO

1	**814221**	**CAPSULORRAFIA DE RODILLA**	Y38	

Cirujano: FERNANDO AGUIRRE LASPRILLA **Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Vía: MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO

1	**817204**	**LIGAMENTORRAFIA O REINSERCION DE LIGAMENTOS VIA ABIERTA**	Y41	

Cirujano: FERNANDO AGUIRRE LASPRILLA **Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Vía: MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO

1	**819520**	**REPARACION O RECONSTRUCCION DEL TENDON ROTULIANO**	Y36	

Cirujano: FERNANDO AGUIRRE LASPRILLA **Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Vía: MIEMBRO INFERIOR DERECHO

1	**837607**	**TRANSFERENCIAS MIOTENDINOSAS DE RODILLA**	Y39	

Cirujano: FERNANDO AGUIRRE LASPRILLA **Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Vía: MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO

1	**867003**	**COLGAJO LOCAL SIMPLE DE PIEL DE CINCO A DIEZ CENTIMETROS CUA DRADOS**	Y38	

Cirujano: FERNANDO AGUIRRE LASPRILLA **Especialidad:** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Vía: MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO

DESCRIPCIÓN CIRUGÍA

CIRUJANO ES169 FERNANDO AGUIRRE LASPRILLA **Especialidad** ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

043108 **NEURORRAFIA DE NERVIO EN PIERNA**
770701 **SECUESTRECTOMIA, DRENAJE, DESBRIDAMIENTO DE TIBIA O PERONE**
780701 **INJERTO OSEO EN TIBIA O PERONE**
793713 **REDUCCION ABIERTA DE FRACTURA DE TIBIA PROXIMAL CON FIJACION INTERNA**
814221 **CAPSULORRAFIA DE RODILLA**
817204 **LIGAMENTORRAFIA O REINSERCION DE LIGAMENTOS VIA ABIERTA**
819520 **REPARACION O RECONSTRUCCION DEL TENDON ROTULIANO**
837607 **TRANSFERENCIAS MIOTENDINOSAS DE RODILLA**
867003 **COLGAJO LOCAL SIMPLE DE PIEL DE CINCO A DIEZ CENTIMETROS CUA DRADOS**

Dx Preoperatorio: S821 FRACTURA DE LA EPIFISIS SUPERIOR DE LA TIBIA

Dx Postoperatorio: S821 FRACTURA DE LA EPIFISIS SUPERIOR DE LA TIBIA

DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

Tipo de Herida: LIMPIA **Tipo de Anestesia:** BLOQUEO NERVIO **Tipo de Cirugía:** URGENCIAS
Cantidad de Sangrado: 80 **ml.** **Vía:** UNICA VIA
Clasificación de riesgo quirúrgico : **A.S.A :** 0 **NNIS :** 0
Realización Acto Quirúrgico: **Fecha Inicio** 10/11/26 **Fecha Final** 10/11/26
Hora Inicio 12:00:00 **Hora Final** 13:00:00
Tiempo de Perfusión: 0 **Minutos** **Tiempo de Clamp:** 0 **Minutos**

Descripcion Quirúrgica:
DECUBITO SUPINO .
ASEPSIA + ANTISEPSIA EN EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA CON CLORHEXIDINA.
CAMPOS ESTERILES.
EXISTE FRACTURA CONMINUTA DE TIBIA Y PERONE PROXIMAL IZQUIERDA - GRAN CONMINUCIÓN CON PÉRDIDA ÓSEA- SE REALIZA INCISIÓN DE 15 CMS EN REGION LATERAL DE RODILLA .DISECCIÓN POR PLANOS HASTA EL FOCO DE FRACTURA METAEPIFISIARIA DE TIBIA- GRAN CONMINUCIÓN OSEA-
SE REALIZA SECUESTRECTOMIA + DRENAJE Y DESBRIDAMIENTO EN TIBIA IZDA REMOVIENDO REACCIÓN PERIÓSTICA INFLAMATORIA PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE INFECCIÓN Y FAVORECER EL PROCESO DE CONSOLIDACION -
SE REALIZAN MANIOBRAS DE REDUCCIÓN ABIERTA FRACTURA DE TIBIA Y FIJACIÓN INTENRA CON:
-1 PLACA V.A LCP DE 3,5 MM TIBIA PROXIMAL CURVA PEQUEÑA DE 6 AGUJEROS IZQUIERDA.
-2 TORNILLOS CORTICALES DE 3,5 MM (1 X 30 + 1 X 40 MM)
- 3 TORNILLOS DE BLOQUEO DE 3,5 X 30 MM
- 6TORNILLOS DE BLOQUEO DE ANGULO VRIABLE DE 3,5 MM (2 X 60 + 1 X 65 + 3 X 70 MM)

SE VISUALIZA EN EL INTENSIFICADOR DE IMÁGENES, SE COMPRUEBA ADECUADA REDUCCIÓN – FIJACIÓN ESTABLE Y RELACIONES ARTICULARES CONSERVADAS.
APLICACIÓN DE INJERTO OSEO AUTOLOGO EN TIBIA EL CUAL ES TOMADO CON CURETA A TRAVES DE " VENTANA " OSEA EN CORTICAL LATERAL SANA DE LA METÁFISIS PROXIMAL DE TIBIA IPSILATERAL SE OBTIENE 2 CC DE HUESO ESPONJOSO -
SE APLICA SOBRE EL DEFECTO DE LA CONMINUCIÓN EN LA TIBIA-
SE REALIZA ARTROTOMÍA DE RODILLA IZQUIERDA DRENANDO GRAN HEMARTROSIS POSTRAUMATICA DE 120 CC Y RESECANDO FRAGMENTOS OSTEOCONDRALES LIBRES CON EL PROPÓSITO DE DISMINUIR EL RIESGO DE ARTROSIS POSTRAUMÁTICA-
.EXISTE GRAN SINOVITIS POSTRAUMÁTICA EN RODILLA – SE REALIZA SINOVECTOMIA TOTAL DE RODILLA REMOVIENDO PROLIFERACIÓN SINOVIAL REACTIVA.
DISECCION + EXPLORACIÓN DE ESTRUCTURAS TENDINOSAS EXISTE AVULSION OSTEO TENDINOSA DEL TENDÓN ROTULIANO IZQUIERDO - SE DISECAN FIBRAS. SE REGULARIZAN EXTREMOS Y SE REALIZA RECONSTRUCCION DEL TENDON ROTULIANO MEDIANTE “ TUNELIZACIONES SUB CONDRALES EN EL POLO INFERIOR DE LA ROTULA Y RAFIAS SOBRE ESTAS -
SE REALIZA EXPLORACION DE ESTRUCTURAS ANATOMICAS DE LA PIERNA IZQUIERDA - EL NERVIO CIATICO POPLITEO EXTERNO PRESENTA AVULSION TRAUMATICA COMPLETA, SE DISECAN FIBRAS, SE REGULARIZAN EXTREMOS IRREGULARES, SE AFRONTAN BORDES Y SE REALIZA NEURORRAFIA DN PIERNA CON TECNICA TERMINOTERMINAL LOGRANDOSE ADECUDA RECONSTRUCCION-
EXISTE DESGARRO TRAUMÁTICO DEL LIGAMENTO COLATERAL LATERAL DE LA RODILLA EN SUS FIBRAS SUPERFICIALES E INTERMEDIAS CON INESTABILIDAD ARTICULAR SECUNDARIA - DISECCIÓN DE FIBRAS - REGULARIZACION DE LA MISMAS-
SE REALIZA RECONSTRUCCIÓN LIGAMENTARIA LATERAL DE LA RODILLA LOGRANDO REESTABLECER ESTABILIDAD ARTICULAR.
EXISTE AVULSION DE CAPSULA POSTEROLATERAL, SE DISECN FIBRAS Y SE REALIZA CAPSULORRAFIA LOGRANDO RESTABLECER SU ANATOMIA -

EXISTE RUPTURA TRAUMÁTICA DE APROX / 80 % EN EL TENDON SEMIMEMBRANOSO IZQUIERDO. SE DISECAN FIBRAS, SE REGULARIZAN EXTREMOS, SE LE DA AVANCE E INTENTO DE TENORRAFIA TERMINOTERMINAL QUEDANDO A " TENSIÓN " Y CON RIESGO DE DESGARRO POR LO CUAL SE REALIZA REFORZAMIENTO DEL MISMO MEDIANTE TRANSFERENCIA MIOTENDINOSA EN RODILLA CON FIBRAS DEL TENDÓN SEMITENDINOSO IPSILATERAL - SE SUTURA CON PROLENE -SE LOGRA RESTABLECER ANATOMÍA ADECUADAMENTE.
SE REALIZA INTENTO DE CIERRE PRIMARIO DE HERIDA, QUEDANDO ÁREA QUE NO PERMITE AFRONTACION PRIMARIA POR EL EDEMA GENERADO POR EL TRAUMA Y LA MANIPULACIÓN DE LOS TEJIDOS, MOTIVO POR EL CUAL SE HACE INDISPENSABLE CIERRE MEDIANTE DISECCION DE COLGAJO SIMPLE DE PIEL DE 6 CMS – EL CUAL SE DISECA DE REGION MEDIAL DE LA RODILLA. SE LIBERA , SE ROTA Y SE LE DA AVANCE SOBRE EL DEFECTO PERMITIENDO ADECUADA COBERTURA - SE AFRONTA CON PROLENE- – CURATIVO CON APOSITOS Y VENDAJE-

Complicaciones : **SI** ☐ **NO** ☒

Hallazgos :
- FRACTURA DE TIBIA Y PROXIMAL PROXIMAL IZQUIERDA.
- GRAN CONMINUCION OSEA EN TIBIA.
- GRAN HEMARTROSIS POSTRAUMATICA DE 120 CC

DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

- FRAGMENTOS OSTEOCONDRALES LIBRES INTRA ARTICULARES.
- EL NERVIO TIBIAL ANTERIOR PRESENTA AVULSION TRAUMATICA COMPLETA.
- DESGARRO TRAUMATICO DEL LIGAMENTO COLATERAL MEDIAL DE LA RODILLA EN SUS FIBRAS SUPERFICIALES E INTERMEDIAS CON INESTABILIDAD ARTICULAR SECUNDARIA.
- AVULSION TRAUMATICA DEL TENDON PATELAR COMPROMETIENDO EL MECANISMO DE FLEXO- EXTENSION DE LA RODILLA .
- RUPTURA TRAUMATICA DE APROX / 80 % EN EL TENDON SEMIMEMBRANOSO .

Tejidos enviados a patología : **SI** ☐ **NO** ☒

OTROS PARTICIPANTES

CÓDIGO	NOMBRE	TIPO
ES169	FERNANDO AGUIRRE LASPRILLA	ESPECIALISTA
ES186	MARIO GERMAN OROZCO SANDOVAL	ANESTESIOLOGO
MG205	JUAN PABLO QUINTERO AGRDO	AYUDANTE



FERNANDO AGUIRRE LASPRILLA
Reg. 76-9390/95
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

***** FIN DEL REPORTE *****